

Plan Estratégico de TI
Taller de Formulación del Plan Estratégico de TI
Gerencia y Gobierno de TI - Unidad 2 Actividad 3
Caso: Nueva EPS S.A.
Campo Ariza, Felix Mauricio – Toledo Lugo, Pablo Andrés

1. Punto de partida y alcance

Este documento toma como punto de partida el diagnóstico construido en la Unidad 1 y la selección de marcos desarrollada en la Unidad 2. En ambos ejercicios llegamos a una misma conclusión: el problema de Nueva EPS no se explica únicamente por una herramienta tecnológica o por un proceso aislado. Hay una dificultad de gobierno que atraviesa la forma en que se toman decisiones, se asignan responsabilidades, se administran los datos y se controla el desempeño de los terceros que participan en el procesamiento de cuentas médicas.

A partir de ese diagnóstico identificamos cinco brechas que orientan el plan: capacidad de procesamiento (B1), gobierno de datos (B2), integración entre cuentas médicas y contabilidad (B3), estructura de decisión de TI (B4) y experiencia y continuidad del servicio (B5). El Plan Estratégico de TI (PETI) que se presenta a continuación busca convertir esas brechas en decisiones concretas, responsables claros, iniciativas priorizadas e indicadores que permitan saber si la situación realmente mejora.

En cuanto a los marcos de referencia, mantenemos la decisión tomada por el equipo: COBIT 2019 funciona como columna vertebral del gobierno; el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) de MinTIC aporta una estructura útil para documentar estrategia, gobierno e información; ITIL 4 se utiliza solamente en prácticas operativas donde agrega detalle (cambios, proveedores y niveles de servicio); y NIST AI RMF queda limitado al eventual componente analítico de priorización. La intención no es implantar cuatro marcos completos, sino tomar de cada uno aquello que responde de manera directa al problema.

Alcance de esta versión. Los documentos disponibles no incluyen el plan estratégico corporativo vigente de Nueva EPS ni un organigrama formal de TI. Por esa razón, los objetivos del negocio que aparecen en el mapa de alineación se presentan como objetivos de referencia derivados del diagnóstico. Antes de aprobar una versión definitiva del PETI, estos objetivos deberían contrastarse con la planeación institucional vigente y con los responsables reales de cada área.

2. Situación actual de TI

La situación actual puede resumirse en una idea: existen capacidades tecnológicas y operativas, pero no están suficientemente conectadas por reglas de decisión, responsabilidades de datos y mecanismos de seguimiento que permitan sostener el control en el tiempo. Esto se vuelve especialmente sensible en cuentas médicas, porque allí convergen información clínica, financiera, contractual y regulatoria.

Además, la operación depende de terceros y de sistemas que deben convivir durante la transición. En ese contexto, una falla de integración o un cambio mal gestionado no se queda en TI: puede traducirse en reprocesos, diferencias contables, retrasos de auditoría, incumplimientos de reporte y deterioro de la experiencia del afiliado. Por eso el PETI se concentra primero en ordenar el gobierno y luego en estabilizar la operación.

Brecha	Lectura para el PETI	Marco de apoyo
B1. Capacidad de procesamiento	El rezago de cuentas médicas y la transición tecnológica exigen una lectura realista de capacidad, demanda, cuellos de botella y continuidad.	COBIT EDM02; prácticas ITIL de cambio y niveles de servicio.
B2. Gobierno de datos	No basta con disponer de datos: es necesario definir quién responde por ellos, qué reglas de calidad aplican y cómo se demuestra su trazabilidad.	COBIT APO14; MGGTI, dominio de Gestión de Información.
B3. Integración cuentas médicas y contabilidad	La falta de conciliación consistente entre los procesos aumenta el reproceso y dificulta el control financiero y regulatorio.	COBIT APO10 y DSS06 como apoyo; prácticas de proveedores.
B4. Estructura de decisión de TI	La rotación directiva y la ausencia de derechos de decisión estables hacen que prioridades y controles puedan cambiar con cada administración.	COBIT EDM01 y APO01; MGGTI, dominio de Gobierno de TI.
B5. Experiencia y continuidad	La continuidad depende de servicios críticos y proveedores. A futuro, la analítica también puede introducir riesgos de sesgo, privacidad y explicabilidad.	COBIT EDM03 y MEA03; ITIL 4; NIST AI RMF acotado.

Tabla 1. Síntesis de las brechas que orientan el Plan Estratégico de TI.

3. Propósito, horizonte y principios del plan

3.1 Propósito, horizonte y visión

Proponemos un horizonte inicial de 18 meses. Es suficientemente corto para responder a la situación de intervención y, al mismo tiempo, permite pasar de acciones de estabilización a capacidades de gobierno que puedan mantenerse. El avance se revisaría trimestralmente y el plan se actualizaría de manera formal cada seis meses, o antes si ocurre un cambio regulatorio, directivo o tecnológico que modifique los supuestos del plan.

El propósito del PETI es lograr que la información y la tecnología apoyen de manera confiable la estabilización de cuentas médicas, el control financiero y regulatorio, la continuidad de los servicios y la toma de decisiones. En términos prácticos, el plan debería hacer que las decisiones sean más trazables, que los datos críticos tengan responsables, que los proveedores sean medibles y que los riesgos de TI se discutan junto con los riesgos del negocio.

La visión a 18 meses es contar con una función de TI y datos más gobernada, medible y resiliente: una función capaz de procesar y conciliar información crítica con calidad y oportunidad, y de sostener sus decisiones aunque cambien las personas que ocupan los cargos directivos.

3.2 Principios que orientan el plan

- Primero definir la decisión, luego la herramienta: toda inversión o cambio relevante debe tener un responsable, un beneficio esperado, un riesgo conocido y una instancia que lo apruebe.
- Los datos se gestionan como un activo del negocio: calidad, trazabilidad, seguridad y responsabilidad no son tareas exclusivas del área de TI.
- Adopción proporcional: se aplican únicamente los objetivos y prácticas de los marcos que aportan a las brechas B1 a B5; no se busca implantar marcos completos por cumplimiento formal.

- Continuidad institucional: los acuerdos críticos deben quedar documentados en mecanismos que sobrevivan a cambios de interventor o de directivos.
- Medir para decidir: cada iniciativa debe tener evidencia, indicador, responsable y criterio de cierre.
- Participación real de las áreas de negocio: Auditoría Médica, Finanzas, Operaciones, Riesgos y Servicio al Afiliado deben participar en las decisiones tecnológicas que afectan sus procesos.

4. Objetivos estratégicos de TI

Para formular los objetivos usamos la lógica de cascada de COBIT 2019: partimos de la necesidad organizacional, la traducimos en un objetivo de TI y, después, la conectamos con los objetivos COBIT y con iniciativas concretas. Esto evita que el plan se convierta en una lista de proyectos tecnológicos sin relación visible con el problema de gobierno.

Código	Objetivo estratégico de TI	Resultado esperado a 18 meses	Marco relacionado
OTI-1	Institucionalizar el gobierno de TI y de datos con roles, instancias y derechos de decisión claramente definidos.	Que las decisiones relevantes queden documentadas, tengan responsables y mantengan continuidad frente a cambios directivos.	EDM01, APO01; MGGTI Gobierno de TI
OTI-2	Estabilizar la capacidad tecnológica que soporta cuentas médicas y gestionar de forma controlada los cambios en sistemas críticos.	Reducir el rezago, mejorar el desempeño y evitar que los cambios tecnológicos generen interrupciones o reprocesos.	EDM02; ITIL 4
OTI-3	Establecer un esquema de gobierno y calidad de datos para cuentas médicas, contabilidad y reportes regulatorios.	Contar con datos críticos con responsables, reglas de calidad, trazabilidad y conciliación verificable.	APO14; DSS06 como apoyo; MGGTI Información
OTI-4	Fortalecer el gobierno de proveedores y los niveles de servicio asociados a plataformas y auditoría tercerizada.	Hacer explícitos los compromisos de desempeño, los mecanismos de escalamiento y la responsabilidad sobre los servicios tercerizados.	APO10; ITIL 4
OTI-5	Gestionar de forma integrada el riesgo tecnológico, el cumplimiento y la continuidad de los servicios críticos.	Tener riesgos priorizados, tratamientos activos, evidencia de cumplimiento y seguimiento sobre continuidad.	EDM03, MEA03; NIST AI RMF cuando aplique

Tabla 2. Objetivos estratégicos de TI y su relación con los marcos priorizados.

El núcleo COBIT se mantiene deliberadamente acotado a ocho objetivos: EDM01, EDM02, EDM03, APO01, APO05, APO10, APO14 y MEA03. DSS06 se utiliza como apoyo para los controles del proceso de negocio, pero no se incorpora como un noveno objetivo del núcleo. Esta decisión conserva la regla de diseño acordada por el equipo para no sobredimensionar la propuesta.

5. Mapa de alineación TI-negocio

Como no contamos con los objetivos corporativos oficiales, construimos un conjunto provisional de objetivos del negocio que resume las necesidades que aparecen de forma consistente en el diagnóstico. El mapa no pretende reemplazar la planeación estratégica de Nueva EPS; sirve para mostrar la lógica de alineación que debería validarse con la organización.

Código	Objetivo organizacional de referencia
OE-1	Estabilizar el procesamiento y la auditoría de cuentas médicas, reduciendo rezago y reproceso.
OE-2	Asegurar información confiable, trazable y oportuna para control financiero, contabilidad y reporte regulatorio.
OE-3	Fortalecer el control sobre recursos, terceros y procesos críticos de la operación.
OE-4	Proteger la continuidad del servicio y favorecer una experiencia más oportuna y predecible para el afiliado.
OE-5	Asegurar continuidad institucional, rendición de cuentas y decisiones sostenibles durante la intervención.

Objetivo TI	OE-1	OE-2	OE-3	OE-4	OE-5	Contribución principal
OTI-1	•	•	•		•	Define quién decide, quién responde y cómo se documenta el gobierno.
OTI-2	•			•		Mejora capacidad, confiabilidad y control del cambio en sistemas críticos.
OTI-3	•	•	•			Mejora calidad, conciliación y trazabilidad entre cuentas médicas y contabilidad.
OTI-4	•		•	•		Convierte la tercerización en servicios medibles y exigibles.
OTI-5		•	•	•	•	Integra riesgo, cumplimiento, continuidad y seguimiento.

Tabla 3. Mapa de alineación TI–negocio. El punto indica una contribución directa del objetivo de TI al objetivo organizacional de referencia.

Cascada de metas COBIT 2019. Para que el mapa anterior sea trazable al marco principal, la Tabla 4 conecta cada objetivo organizacional de referencia con las metas empresariales (EG) de COBIT 2019, cada objetivo de TI con las metas de alineamiento (AG) y estas con los objetivos de gobierno y gestión priorizados y con la iniciativa que los materializa (ISACA, 2018, figuras 4.6

y 4.18). La cascada se lee de izquierda a derecha: necesidad del negocio, meta empresarial, objetivo de TI, meta de alineamiento, objetivos COBIT e iniciativa.

Objetivo del negocio	Meta empresarial COBIT (EG)	Objetivo de TI	Meta de alineamiento COBIT (AG)	Objetivos COBIT priorizados (hipótesis)	Iniciativa
OE-5, OE-3	EG11 Cumplimiento de políticas internas; EG02 Riesgo de negocio gestionado	OTI-1	AG11 Cumplimiento de TI con las políticas internas; AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones habilitadas por TI	EDM01, APO01, APO05 (H1, H6)	I1 Comité de Gobierno de TI y Datos
OE-1, OE-4	EG08 Optimización de la funcionalidad de los procesos internos; EG06 Continuidad y disponibilidad del servicio	OTI-2	AG05 Entrega de servicios de TI conforme a los requisitos del negocio; AG08 Habilitación de los procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones y tecnología	EDM02, APO05; BAI06 como apoyo (H1, H2)	I3 Estabilización y capacidad
OE-2, OE-1	EG04 Calidad de la información financiera; EG07 Calidad de la información de gestión	OTI-3	AG10 Calidad de la información de gestión de TI; AG07 Seguridad de la información y privacidad	APO14; DSS06 como apoyo (H3)	I2 Gobierno de datos y conciliación
OE-3, OE-1	EG09 Optimización de los costos de los procesos de negocio; EG06 Continuidad y disponibilidad del servicio	OTI-4	AG05 Entrega de servicios de TI conforme a los requisitos del negocio; AG03 Beneficios obtenidos del portafolio de servicios	APO10 (H5)	I4 Gobierno de proveedores y SLA
OE-2, OE-4, OE-5	EG03 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas; EG02 Riesgo de negocio gestionado	OTI-5	AG01 Cumplimiento de TI y apoyo al cumplimiento regulatorio del negocio; AG02 Riesgo relacionado con TI gestionado	EDM03, MEA03; APO12 como apoyo (H4, H7)	I5 Tablero de desempeño, riesgo y cumplimiento

Tabla 4. Cascada de metas COBIT 2019 aplicada al plan: del objetivo del negocio a la iniciativa. Códigos EG y AG según ISACA (2018).

6. Iniciativas estratégicas priorizadas

La priorización se hizo con tres criterios sencillos: impacto sobre las brechas (40 %), viabilidad en el contexto actual (30 %) y reducción de riesgo (30 %). La escala de 1 a 5 funciona como apoyo para ordenar la conversación, no como una verdad matemática. En una versión definitiva, los puntajes deberían revisarse con responsables de negocio, TI, riesgos y presupuesto.

Prioridad	Iniciativa	Impacto	Viabilidad	Reducción de riesgo	Puntaje /5	Justificación
1	I1. Formalizar el Comité de Gobierno de TI y Datos y su RACI	5	5	5	5,00	Es la condición habilitante. Sin derechos de decisión claros, las demás iniciativas pueden quedarse sin dueño o perder continuidad.
2	I2. Implementar gobierno de datos y conciliación cuentas médicas–contabilidad	5	4	5	4,70	Interviene dos brechas de raíz (B2 y B3) y mejora la trazabilidad que necesitan Finanzas, Auditoría Médica y cumplimiento.
3	I3. Estabilizar capacidad y operación de Factrmed / sistemas críticos	5	3	5	4,40	Tiene impacto directo sobre el rezago y la continuidad. Su viabilidad depende en mayor medida de capacidades técnicas y del proveedor.
4	I4. Fortalecer gobierno de proveedores, SLA y gestión de cambios	4	5	4	4,30	Permite controlar una operación altamente tercerizada y acordar cómo se mide, escala y corrige un incumplimiento.
5	I5. Consolidar un tablero de desempeño, riesgo y cumplimiento	4	4	4	4,00	Hace visible el avance del PETI y evita que las decisiones se basen sólo en percepciones. Incluye salvaguardas para analítica cuando aplique.

Tabla 5. Priorización inicial de iniciativas estratégicas.

6.1 Qué esperamos lograr con cada iniciativa

I1. Comité de Gobierno de TI y Datos. El resultado esperado no es simplemente “crear otro comité”. La iniciativa debe dejar un mecanismo estable para decidir sobre inversiones, riesgos, arquitectura, datos y prioridades. Sus primeros productos serían un acto de creación, reglamento, RACI, catálogo de decisiones, calendario y repositorio de actas. La participación de Finanzas, Auditoría Médica, Riesgos, Operaciones y Servicio al Afiliado es esencial para que el gobierno no quede encerrado en TI.

I2. Gobierno de datos y conciliación. La prioridad es empezar por los datos que soportan cuentas médicas, contabilidad y reporte. Se requieren dueños y custodios de datos, definiciones comunes, reglas de calidad, linaje, controles de conciliación y un plan para resolver diferencias. El objetivo es que una cifra crítica pueda explicarse desde su origen hasta el reporte final.

I3. Estabilización y capacidad. Antes de exigir más velocidad al sistema, necesitamos una línea base que muestre dónde están los cuellos de botella. Esta iniciativa incluye medición de capacidad, control de cambios, criterios de aceptación, continuidad, recuperación y un plan explícito de reducción del rezago. La estabilización tecnológica debe ir de la mano con el dueño del proceso de cuentas médicas.

I4. Gobierno de proveedores y SLA. Dado el peso de la tercerización, los contratos y acuerdos de servicio deben traducirse en indicadores concretos. La iniciativa contempla segmentación de proveedores críticos, acuerdos de nivel de servicio y de nivel operativo (SLA y OLA), responsables, escalamiento, evaluación mensual y evidencia de continuidad. La meta es que el desempeño de un tercero sea discutible con datos y no únicamente con percepciones.

I5. Tablero de desempeño, riesgo y cumplimiento. El PETI necesita un mecanismo visible de seguimiento. Este tablero integraría indicadores de operación, datos, proveedores, riesgos y decisiones del comité. Si se implementa el modelo

analítico de priorización de auditoría, se incorporaría una ficha de riesgo alineada con NIST AI RMF para documentar aspectos como sesgo, privacidad, explicabilidad y monitoreo.

7. Estructura preliminar de toma de decisiones

Uno de los aprendizajes del diagnóstico es que mejorar la tecnología sin aclarar quién decide puede producir avances temporales pero no un cambio sostenible. Por eso proponemos una estructura sencilla: la alta dirección conserva las decisiones de mayor impacto; un Comité de Gobierno de TI y Datos integra negocio y tecnología; TI mantiene la responsabilidad técnica; y los dueños de proceso conservan la responsabilidad por beneficios, datos y niveles de servicio.

Instancia / rol	Quién participa	Qué decide o gestiona	Cómo participa el negocio
Junta Directiva / instancia equivalente e Interventor	Alta dirección, interventor y responsables de control.	Aprueba PETI, presupuesto, apetito de riesgo, inversiones mayores y excepciones críticas.	Recibe resultados de valor, riesgo, cumplimiento y continuidad; exige planes de acción.
Comité de Gobierno de TI y Datos	Interventor o delegado; TI; Finanzas; Auditoría Médica; Riesgos/Compliance; Operaciones; Servicio al Afiliado; Jurídica/Contratación.	Prioriza portafolio, decide sobre cambios mayores y arquitectura, define dueños de datos, revisa indicadores clave de desempeño y de riesgo (KPI y KRI) y resuelve conflictos.	Las áreas de negocio son miembros activos y responden por beneficios, prioridades y calidad de la información.
Liderazgo de TI	Aplicaciones, infraestructura, seguridad, arquitectura y servicio.	Diseño técnico, operación, capacidad, continuidad, cambios estándar y propuestas de inversión.	Trabaja con dueños de proceso para requisitos, aceptación y niveles de servicio.
Mesa de Datos	Dueños y custodios de datos de cuentas médicas, Finanzas, Auditoría, Servicio y TI.	Definiciones, reglas de calidad, accesos, trazabilidad, conciliación e incidentes de datos.	El negocio conserva la propiedad semántica de la información y aprueba reglas críticas.
Dueños de proceso / servicio	Auditoría Médica, Finanzas, Operaciones, Servicio al Afiliado y Riesgos.	Necesidades, beneficios esperados, SLA, criterios de aceptación y priorización funcional.	Son responsables de validar que la solución realmente genere valor en el proceso.
Planeación / Riesgos / Control Interno	Planeación, riesgos, control y apoyo de TI.	Seguimiento de hoja de ruta, riesgos, dependencias, indicadores y escalamiento.	Consolida evidencia para la dirección y los órganos de control.

Tabla 6. Estructura preliminar de gobierno y participación de las áreas de negocio.

Como cadencia inicial, proponemos que el Comité de Gobierno de TI y Datos se reúna mensualmente; la mesa de datos, cada dos semanas durante los primeros seis meses y después de forma mensual; y la revisión ejecutiva del PETI se realice cada trimestre. Esta frecuencia puede ajustarse cuando la operación se establezca.

7.1 Derechos de decisión

Tipo de decisión	Propone	Decide / aprueba	Consulta obligatoria	Evidencia mínima
Prioridad de iniciativas e inversión	Líder de TI + dueño de negocio	Comité / Junta según umbral	Finanzas, Riesgos y Planeación	Caso de negocio, análisis de riesgo y acta
Arquitectura o integración crítica	Arquitectura TI	Comité de Gobierno TI y Datos	Datos, Seguridad y dueños de proceso	Decisión de arquitectura
Reglas de datos y calidad	Data steward / custodio	Data owner / Mesa de Datos	TI, Riesgos y Auditoría	Diccionario, regla y evidencia de trazabilidad

Tipo de decisión	Propone	Decide / aprueba	Consulta obligatoria	Evidencia mínima
Cambio mayor en sistema crítico	TI / proveedor	Comité de cambios o Comité de Gobierno según impacto	Dueño de proceso, Seguridad y Continuidad	Solicitud de cambio, pruebas y plan de reversa
SLA de proveedor crítico	TI + dueño del servicio	Comité de Gobierno / Contratación	Jurídica, Finanzas y Riesgos	SLA, KPI y esquema de escalamiento
Aceptación de riesgo alto	Riesgos + TI	Interventor / Junta según apetito	Dueño de proceso, Seguridad y Compliance	Registro de riesgo y aceptación formal

Tabla 7. Matriz simplificada de derechos de decisión.

8. Indicadores iniciales de desempeño

Los indicadores buscan responder dos preguntas diferentes: si la operación está mejorando y si el modelo de gobierno está funcionando. La columna "Objetivo / iniciativa" indica a qué objetivo de TI y a qué iniciativa responde cada indicador, de modo que el avance del plan pueda leerse desde la cascada de metas de la Tabla 4. Las metas se presentan como referencias iniciales. Durante los dos primeros meses del PETI debe validarse la línea base y, a partir de ella, ajustar los compromisos para evitar metas desconectadas de la capacidad real.

Indicador	Objetivo / iniciativa	Definición / fórmula	Frecuencia	Meta inicial
KPI-1. Reducción del rezago	OTI-2 / I3	$(\text{Rezago base} - \text{rezago actual}) / \text{rezago base} \times 100$	Mensual	$\geq 60\%$ a 12 meses*
KPI-2. Procesamiento dentro de SLA	OTI-2 / I3	$\text{Cuentas procesadas dentro del tiempo acordado} / \text{total procesadas} \times 100$	Mensual	$\geq 95\%$
KPI-3. Conciliación médico-contable	OTI-3 / I2	$\text{Registros conciliados sin diferencia} / \text{total sujeto a conciliación} \times 100$	Mensual	$\geq 98\%$
KPI-4. Calidad de datos críticos	OTI-3 / I2	$\text{Registros que cumplen reglas críticas} / \text{total evaluado} \times 100$	Mensual	$\geq 98\%$
KPI-5. Reportes regulatorios oportunos	OTI-5 / I5	$\text{Reportes completos y enviados dentro del plazo} / \text{total exigible} \times 100$	Mensual / trimestral	100 %
KPI-6. Cumplimiento de SLA de proveedores	OTI-4 / I4	$\text{Indicadores de SLA cumplidos} / \text{SLA medidos} \times 100$	Mensual	$\geq 95\%$
KPI-7. Disponibilidad de servicios críticos	OTI-2 / I3	$\text{Minutos disponibles} / \text{minutos comprometidos} \times 100$	Mensual	$\geq 99,5\%$ **
KPI-8. Cambios fallidos	OTI-2 y OTI-4 / I4	$\text{Cambios que causan incidente, reversa o degradación} / \text{cambios totales} \times 100$	Mensual	$< 10\%$
KPI-9. Riesgos altos con tratamiento al día	OTI-5 / I5	$\text{Riesgos altos con plan vigente y acciones en plazo} / \text{riesgos altos totales} \times 100$	Mensual	$\geq 90\%$
KPI-10. Decisiones cerradas a tiempo	OTI-1 / I1	$\text{Acuerdos cerrados dentro del plazo} / \text{total de acuerdos vencidos o por vencer} \times 100$	Mensual	$\geq 90\%$

Tabla 8. Indicadores preliminares para seguimiento del PETI. * Meta a validar con línea base. ** Debe definirse por servicio y ventana comprometida.

9. Hoja de ruta preliminar a 18 meses

La secuencia de implementación prioriza primero las reglas de gobierno y la línea base. Después se concentra en datos, capacidad y proveedores; y sólo cuando existe información de seguimiento suficiente se pasa a consolidar el tablero, evaluar capacidades y ajustar el plan. Esto permite avanzar sin intentar transformar toda la función de TI al mismo tiempo.

Fase	Periodo	En qué se concentra	Hito de salida
Fase 0. Acordar cómo se gobierna	Meses 0 a 2	Formalizar I1; levantar línea base de KPI y KRI; inventariar servicios, proveedores y datos críticos.	Comité y RACI aprobados; línea base validada; backlog priorizado.
Fase 1. Recuperar control	Meses 3 a 6	Activar I2, I3 e I4: reglas de datos, conciliación, capacidad, cambios y SLA.	Primer ciclo de conciliación; SLA críticos activos; plan de capacidad y continuidad aprobado.
Fase 2. Ejecutar y medir	Meses 7 a 12	Reducir rezago; poner en marcha I5; hacer seguimiento integrado de riesgos y cumplimiento.	Tendencia sostenida de mejora en KPI; decisiones y riesgos con trazabilidad.
Fase 3. Consolidar y ajustar	Meses 13 a 18	Optimizar procesos, auditar evidencia, evaluar capacidad COBIT y actualizar objetivos.	Evaluación de capacidad; lecciones aprendidas; versión actualizada del PETI.

Tabla 9. Hoja de ruta propuesta para la implementación inicial.

10. Riesgos, supuestos y decisiones pendientes

Esta propuesta depende de varios supuestos que deben hacerse visibles desde el inicio. El primero es la continuidad directiva: la estructura sólo tendrá valor si queda formalizada y no depende de una persona. El segundo es la disponibilidad de información interna: todavía no contamos con contratos de Factrmed ni de las firmas auditoras, por lo que los SLA y controles contractuales deberán contrastarse con las condiciones vigentes.

También queda pendiente establecer una línea base formal de capacidad para los objetivos COBIT priorizados. La meta planteada por el equipo de avanzar hacia niveles de capacidad 2 a 3 en un horizonte de 18 meses debe entenderse como una aspiración que requiere diagnóstico inicial. De igual manera, el MGGTI se utiliza aquí como referente de buena práctica y como lenguaje útil para evidencias; no asumimos su obligatoriedad jurídica plena para Nueva EPS sin una validación específica.

Finalmente, NIST AI RMF sólo cobra relevancia si el modelo analítico de priorización llega a diseñarse o ponerse en producción. En ese momento deberá existir una revisión explícita de riesgos de datos, privacidad, sesgo, explicabilidad y monitoreo. Antes de eso, no tiene sentido convertirlo en una capa adicional de gobierno organizacional.

11. Referentes públicos revisados

Para contrastar la estructura del entregable revisamos dos referentes públicos colombianos. El MGGTI de MinTIC organiza la gestión y el gobierno de TI en seis dominios e incluye una guía específica para la construcción del PETI, además de lineamientos sobre esquema de gobierno, gestión de información e indicadores. Por su parte, el PETI 2024-2026 de la Superintendencia Nacional de Salud (2023) presenta una estructura que conecta marco estratégico, alineación de TI con procesos, diagnóstico, estrategia, gobierno e información. Estos referentes se usaron para ordenar la propuesta, no para trasladar mecánicamente estructuras que pertenecen a entidades públicas con contextos distintos.

12. Conclusión

El valor de este PETI no está en producir un documento más, sino en establecer una forma de trabajo que conecte tecnología, datos y decisiones de negocio. En el caso de Nueva EPS, la prioridad es recuperar trazabilidad y control: saber quién decide, con qué información, bajo qué criterios y cómo se verifica el resultado. Si esa base se consolida, las iniciativas de estabilización tecnológica, conciliación de datos y gestión de proveedores tienen una mayor probabilidad de sostenerse en el tiempo.

Por ello, la propuesta empieza por formalizar el gobierno y no por ampliar el portafolio tecnológico. La secuencia planteada busca que cada nuevo control o inversión tenga una razón clara, un responsable y una medida de avance. Con la validación de la línea base, los objetivos corporativos reales y las condiciones contractuales vigentes, este borrador puede evolucionar hacia un PETI definitivo y ejecutable.

13. Referencias

AXELOS. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. AXELOS Limited.

ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Introduction and methodology. ISACA.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano: Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) y guía para la construcción del PETI. <https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/portal/modelomrae/Modelo-de-Gestion-y-Gobierno-TI-MGGTI/>

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>

Superintendencia Nacional de Salud. (2023). Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2024-2026, versión 1. <https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Planes/PT%202024.pdf>